

Сценарій № 1

Ви лікар приймального відділення дитячої клінічної лікарні.

До Вас звернулася мати дитина 5-ти років зі скаргами на підвищення температури у дитини до 38°C, слабкість, млявість, малопродуктивний кашель.

Із анамнеза відомо, що дитина хворіє четверту добу.

В анамнезі життя – ГРВІ 3 рази на рік.

Об'єктивно: стан дитини тяжкий, що обумовлено інтоксикацією та дихальною недостатністю. Перкуторно над легеннями праворуч нижче кута лопатки тупий звук. При аускультації – під лопаткою справа послаблення дихання та дрібноміхурцеві хрипи. ЧД 26/хв. Межі відносної серцевої тупості не розширені. Тонисерця ясні, ритмічні, ЧСС 121 уд/хв. Живіт м'який, безболісний. Печінка не виступає з-під краю реберної дуги. Фізіологічні відправлення без особливостей.

Клінічний аналіз крові

Показник	Дані пацієнта	Нормативні значення
Гемоглобін, г/л	140	110-140
Еритроцити, 10^{12} /л	4,9	3,7-4,9
Кольоровий показник, од	0,9	0,8-1,0
Тромбоцити, 10^9 /л	230	150 – 400
Лейкоцити, 10^9 /л	13,8	5-10
паличкоядерні нейтрофіли, %	8	0,5-5
сегментоядерні нейтрофіли, %	56	25-60
Лімфоцити, %	24	26-60
Еозинофіли, %	4	1-5
Моноцити, %	8	2-10
ШОЕ, мм/год	31	4-12



Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Встановити контакт з пацієнтом та батьками/опікунами (привітатись, представитися, позначити свою роль). Коректне розташування лікар-пацієнт	Сказати Доброго дня. Я лікар педіатр.
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного обстеження дитини	Сказати Чи даєте Ви свою згоду на проведення клінічного обстеження Вашої дитини (Будемо вважати що згода отримана)
2.Збір скарг та анамнезу		
2.1	Скарги пацієнта (зі слів батьків/опікунів)	Сказати: Скільки років дитині? Очікувана відповідь: 5 років Сказати: Які скарги у дитини? Очікувана відповідь: на підвищення температури тіла у дитини до 38°C, слабкість, млявість, малопродуктивний кашель
2.2	Анамнез захворювання	Сказати:Як довго дитина хворіє? Очікувана відповідь: хворіє четверту добу
2.3	Анамнез життя	На які захворювання дитина хворіла? Алергія? Травми/операції? Щеплення? Спадковість?
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавички	Виконати/сказати Будемо вважати, що руки оброблені
3.2	Загальний стан.	Сказати:стан дитини тяжкий, що обумовлено інтоксикацією та дихальною недостатністю.
3.3	Обстеження дихальної системи	Сказати:Перкуторно над легеньми – праворуч нижче кута лопатки тупий звук. При аускультції – під лопаткою справа послаблення дихання та дрібноміхурцеві хрипи
4.Діагностика		
4.1	Визначити результатклінічного аналізу крові	Сказати: лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво, прискорене ШОЕ

4.2	Визначити результат рентгенологічного дослідження органів грудної клітки	Патологічні тінеутворення вогнищевого характеру у нижній долі правої легені
4.3	Визначити провідний синдром	Сказати: інтоксикаційний та дихальної недостатності
4.4	Встановити клінічний діагноз	Негоспітальна правобічна вогнищева нижньодольова пневмонія. Гострий перебіг. Неускладена. ДН 1ст.
5. Визначення тактики ведення та лікування		
5	Призначити подальшу тактику ведення пацієнта	Госпіталізація в стаціонар у пульмонологічне відділення, призначення антибактеріальної терапії – в/в ампіцилін 150 мг на кг на добу у 3 введення.
6. Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	раціональне харчування, загартовування, санація вогнищ хронічної інфекції. Вакцинація від пневмококу.
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування пацієнта/батьків/опікунів про можливі ризики та етичні аспекти	Ви повинні знати про можливі ускладнення пневмонії – ексудативний плеврит, пневмоторакс, Дих недост.